

Departamento de Ortopedia y Neurocirugía Espinal
Av. Universidad 450, Col. Lomas • Tel: (55) 5420-9800

Aseguradora:	Seguros Médicos del Centro, S.A.	Paciente:	García Hernández, Carlos M.
Dpto. de Quejas:	Comité de Revisión y Arbitraje	Póliza / ID:	SMC-99482103-01
No. Siniestro / Caso:	DEN-2026-8812-CL	Fecha Nacimiento:	14/04/1982
Procedimiento:	CPT 72148 (RMN Columna Lumbar)	Diagnósticos:	M54.5 (Lumbago), M51.1 (Radiculopatía)

ASUNTO: Apelación formal de primera instancia contra la denegación de cobertura para *Resonancia Magnética de Columna Lumbar sin contraste (CPT 72148)*.

1. DECLARACIÓN DE INTENCIÓN Y MOTIVO DE DENEGACIÓN

Por medio de la presente, actuando en representación médica del paciente **Carlos M. García Hernández**, solicitamos la reconsideración formal y revocación de la resolución emitida con fecha **02 de Agosto de 2026**, mediante la cual se denegó la autorización previa para el procedimiento arriba citado bajo el criterio de *"Falta de justificación médica / No agotamiento de terapia conservadora"*.

2. RESUMEN CLÍNICO Y NECESIDAD MÉDICA

El paciente acudió con cuadro clínico de lumbociatalgia incapacitante de 8 semanas de evolución, irradiada al miembro pélvico derecho sobre el dermatoma L5, asociada a parestesias y paresia distal (fuerza motora 4/5 en dorsiflexión). A la exploración física se constata **signo de Lasègue positivo a 35°** en pierna derecha y reflejo aquileo disminuido (+/++++).

Dichos hallazgos reflejan un compromiso radicular agudo con compresión neural activa, cumpliendo con la necesidad imperativa de diagnóstico por imagen para definir conducta quirúrgica vs. descompresiva guiada.

3. EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO DE MANEJO CONSERVADOR

La denegación argumenta erróneamente la carencia de manejo conservador documentado. Se adjunta el expediente cronológico que certifica el agotamiento estricto de las líneas terapéuticas requeridas:

Periodo / Fecha	Intervención Clínica	Resultado / Observaciones
12/06/2026 - 24/07/2026 (6 semanas completas)	Fisioterapia y Rehabilitación Lumbar 18 sesiones documentadas por Servicio de Medicina Física.	Evolución refractaria. Persistencia de dolor EVA 8/10 y claudicación a la marcha.
10/06/2026 - Presente	Farmacoterapia de Primera Línea AINEs (Celecoxib 200mg/día) + Neuromodulador (Pregabalina 75mg c/ 12h).	Alivio sintomático nulo del dolor radicular neuropático.
28/07/2026	Evaluación Neurológica de Control	

Periodo / Fecha	Intervención Clínica	Resultado / Observaciones
		Déficit sensorial progresivo en territorio L5 derecho.

4. SUSTENTO NORMATIVO Y GUÍAS CLÍNICAS (LCD / CRITERIOS DE COBERTURA)

De acuerdo con la Determinación de Cobertura Local (**CMS LCD L34212**) y los *Clinical Coverage Criteria for Lumbar Spine MRI*:

"La resonancia magnética lumbar está médicamente indicada tras al menos 4 a 6 semanas de manejo conservador documentado (fisioterapia, analgesia guiada) en presencia de signos radiculares objetivos o déficit neurológico progresivo."

El caso cumple a cabalidad con dichos lineamientos, demostrando más de 6 semanas de manejo conservador inefectivo y signos de compresión radicular documentados.

5. PETICIÓN CONCRETA Y CONCLUSIÓN

Exigimos la autorización expedita del estudio **CPT 72148** en un plazo no mayor a 5 días hábiles a fin de evitar un daño neurológico permanente e irreversible al paciente. Nos reservamos el derecho de elevar esta reclamación ante los organismos regulatorios de arbitraje médico pertinentes en caso de negativa injustificada.

Dr. Alejandro Morales Villarreal

Médico Especialista en Traumatología y Ortopedia
Cédula Profesional: 8492019 / Reg. Esp: 49201

Carlos M. García Hernández

Paciente / Asegurado Titular
Firma de Conformidad